

Лобково-симфизарный свищ (Мочевой свищ лобковой кости)

WARWIKI

Информация для пациента · Когда моча разрушает лобковую кость, вызывая боль и инфекцию

Лобково-симфизарный свищ (также называемый уросимфизарным свищом) — это патологическое соединение между **мочевыводящим трактом** (шейкой мочевого пузыря или уретрой) и **лобковым сочленением** спереди таза, как правило сопровождающееся инфекцией кости. Состояние вызывает сильную боль в лобке и паху, затрудняет ходьбу. Оно редкое и серьёзное, однако существует чёткая тактика лечения.

Об этом состоянии

Моча, воздействующая на лобковую кость, вызывает остеомиелит и разрушение сустава. Типичные симптомы:

- **Сильная боль в лобке, паху или тазу**, усиливающаяся при ходьбе
- Трудности при ходьбе или опоре на ногу
- Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей; иногда подтекание мочи

Боль нередко поначалу принимают за артрит или ортопедическую проблему, что задерживает диагноз.

Причины

Почти всегда это позднее осложнение **лечения рака простаты** — особенно **лучевой терапии**, нередко после предшествующих вмешательств на шейке мочевого пузыря или уретре. Облучённые ткани плохо заживают, позволяя моче разрушать кость.

ТЕРМИНЫ

Лобковый симфиз

Сустав, соединяющий лобковые кости спереди таза.

Лобково-симфизарный свищ

Соединение между мочевыводящим трактом и этим суставом/костью.

Остеомиелит

Инфекция кости.

MRI

Магнитно-резонансная томография — лучший метод визуализации кости и свища.

Дебридмент

Хирургическое удаление инфицированной кости и ткани.

Отведение мочи

Перенаправление мочи от поражённой зоны — часто единственное долгосрочное решение.

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ ТАКОЕ АГРЕССИВНОЕ? Потому что речь идёт об **инфицированных, плохо заживающих (часто облучённых) тканях и кости**: простое «залатывание» почти никогда не помогает. Стойкое избавление от боли требует удаления инфицированной кости и **отведения мочи от этой зоны** — именно поэтому нередко рекомендуется деривация мочи. Итог — возможность наконец завершить многолетние страдания.

Как это диагностируют

- **MRI** таза (лучший метод для оценки кости) и осмотр уретры/ мочевого пузыря изнутри
- Посевы для выявления возбудителя инфекции
- Подробный анамнез — предшествующее лечение рака простаты, облучение и процедуры

Как это лечат

- 1 **Антибиотики** для лечения инфекции кости.
- 2 **Операция по удалению инфицированной кости** (дебридмент) и санация зоны.
- 3 **Отведение мочи** — многим пациентам в конечном счёте требуется **деривация мочи** (а иногда удаление повреждённого мочевого пузыря/уретры), поскольку облучённые ткани иначе не заживут.
- 4 **Лоскут ткани** — в зону дефекта может быть перемещена здоровая мышца или сальник для заполнения и заживления.

Лечение, как правило, **мультидисциплинарное** (урология совместно с ортопедической и/или пластической хирургией).

Полезно знать

- Если после лучевой терапии на простате у вас появилась необъяснимая боль в лобке — сообщите врачу об этом состоянии: его легко пропустить.
- Деривация мочи звучит пугающе, но нередко именно она наконец **устраняет боль** и инфекцию.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- **Повышение температуры, озноб или резкое ухудшение самочувствия** (возможное распространение инфекции)
- Нарастающая боль в лобке/паху или **невозможность ходить**
- Острая задержка мочеиспускания или обильное кровотечение

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Лобково-симфизарный свищ позволяет моче разрушать лобковую кость, вызывая сильную боль и остеомиелит — как правило, спустя годы после облучения простаты.
2. Его часто принимают за артрит; диагноз устанавливают с помощью MRI. Сообщите своей команде о предшествующей лучевой терапии.
3. Лечение включает удаление инфицированной кости и, как правило, деривацию мочи — агрессивный подход, который может наконец избавить от боли.